SDD 94 Sujet n°1

Spécialité : Endocrinologie-Gynécologie

Date : 25/11/2023
Auteur : SAMANNI Léa (DES Endocrinologie-Diabétologie-Nutrition, ECN 2023)
Relecteur(s) : ELAYLI Robin (DES Psychiatrie Grenoble, ECN 2023), Lucie-Lou VIAL (DES MAR, EDN 2023/2024)

Domaine d'apprentissage principal	Entretien/interrogatoire
Domaine d'apprentissage secondaire	Stratégie diagnostique
Item(s) en lien avec la station	Item 42- Aménorrhée Item 35 - Anomalies du cycle menstruel
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 94 - Troubles du cycle menstruel
Matériel nécessaire à la station	1 bureau et 2 chaises
Contexte de la station	Vous êtes médecin généraliste et recevez en consultation Mme.JILOU, 25 ans. Celle-ci présente une aménorrhée secondaire.

-

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes médecin généraliste en ville.
Vous recevez Mme. JILOU, âgée de 25 ans au cabinet. Celle-ci présente une aménorrhée secondaire depuis maintenant 6 mois. Elle est très inquiète.

L'examen clinique est normal. Mme. JILOU est asymptomatique. Il n'existe pas de galactorrhée (ni spontanée, ni provoquée) et les organes génitaux externes sont normaux.

Consignes :
Vous avez 8 minutes pour :

- Réaliser l'interrogatoire complet de la patiente
- Proposer des explorations paracliniques

Vous ne devez pas :

- Réaliser l'examen clinique
- Réaliser d'ordonnance
- Adresser votre patiente à un spécialiste

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station avec patient standardisé.

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)			
1.	L'étudiant(e) questionne la patiente sur la possibilité d'une grossesse avec au moins 2 éléments recherchés parmi les 3 suivants: - *Rapports sexuels réguliers ?* - *Date du dernier rapport sexuel ?* - *Utilisation d'une contraception ?/Laquelle ?*	1 pt	☐
2.	L'étudiant(e) questionne la patiente sur ses antécédents personnels médicaux et chirurgicaux.	1 pt	☐
3.	L'étudiant(e) questionne la patiente sur ses antécédents gynécologiques : Demande nombre de grossesse ET nombre d'accouchement	1 pt	☐
4.	L'étudiant questionne la patiente sur la régularité de ces cycles antérieurs (demande les 3 éléments) : ● Recherche s'il y avait des menstruations irrégulières en terme de fréquence ● Recherche la durée moyenne de ces menstruations auparavant ● Recherche la quantité de sang perdue estimée en moyenne (Nombre de protections utilisées par jour)	1 pt	☐
5.	L'étudiant(e) questionne la patiente sur ses éventuels traitements/prises médicamenteuses.	1 pt	☐
6.	L'étudiant recherche des signes de carence oestrogénique : ***(au moins 2 éléments pour avoir le point)*** - Bouffées de chaleur - Sécheresse vaginale et dyspareunie - Troubles du sommeil/troubles psychiques - Baisse de la libido - Arthralgies	1 pt	☐
7.	L'étudiant demande à la patiente son IMC OU les éléments permettant de le calculer (son poids ET sa taille)	1 pt	☐
8.	L'étudiant recherche une perte de poids récente.	1 pt	☐
9.	L'étudiant évalue l'activité physique de la patiente.	1 pt	☐

10.	L'étudiant questionne la patiente sur son alimentation (de manière générale) *Recherche d'une restriction alimentaire, éviction de certains aliments notamment les lipides, présence d'un trouble du comportement alimentaire ?*	1 pt	☐
11.	L'étudiant recherche des signes d'hyperandrogénie : ***(les 3 éléments sont nécessaires pour avoir le point)*** - Acné/séborrhée - Hirsutisme - Alopécie	1 pt	☐
11.	L'étudiant propose de réaliser un dosage des béta-HCG plasmatiques.	1 pt	☐
12.	L'étudiant propose de réaliser un dosage de l'oestradiolémie	1 pt	☐
13.	L'étudiant propose de réaliser un dosage des gonadotrophines hypophysaires (LH et FSH).	1 pt	☐
14.	L'étudiant propose de réaliser un dosage de la prolactinémie *Peuvent être évoqués sans pénaliser l'étudiant :* *- Une testostéronémie totale* *- Une échographie pelvienne*	1 pt	☐
Communications et attitudes (ICI) (max 5 grilles)			
1.	**1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair**	1 pt	☐

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

2.	**2. APTITUDE À QUESTIONNER**	1 pt	☐

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

3.	**8. APTITUDE À FAIRE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES**	1 pt	☐

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
N'arrive pas à faire ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème quelquefois sans les justifier	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Fait ressortir les éléments positifs et négatifs pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Agit avec assurance et sans erreur

TOTAL (/16 points)	**X points**

<u>Éléments de rétroaction :</u>

Être systématique dans le bilan d'une aménorrhée :

- Éliminer d'abord et avant tout une grossesse
- Réaliser un bon interrogatoire, complet +++
- Et un examen clinique ciblé, à la recherche d'éléments vous orientant vers certaines étiologies "classiques" :

● Signes d'hyperandrogénie dans le SOPK
● Galactorrhée dans les hyperprolactinémie
● Signes de carence oestrogénique dans l'IOP
● Poids/taille/IMC, qui peuvent assez facilement vous mener vers une aménorrhée hypothalamique fonctionnelle.

Causes les plus fréquentes d'aménorrhée à retenir :

- La grossesse +++ => au moindre doute (voire systématiquement), b-hCG
- Le SOPK (5 à 10% des femmes)
- Les hyperprolactinémies (penser aux causes médicamenteuses +++)
- les aménorrhées hypothalamiques fonctionnelles : liées à un stress important, une perte de poids rapide et significative ou encore une anorexie mentale, une hyperactivité physique, un défaut de masse grasse et d'apports lipidiques.

ECOS TACFA
SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Mme. JILOU, 25 ans. Célibataire.
Aménorrhée secondaire depuis maintenant 6 mois.
Consulte son médecin traitant, très inquiète.

Plan de la station ECOS :

Patiente assise face à l'étudiant.e.

<u>Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :</u>

"Voilà docteur, cela fait 6 mois que je n'ai plus mes règles. Ça m'inquiète beaucoup. Je ne comprends pas…
Je suis presque certaine de ne pas être enceinte !"

Identité du patient :

Mme. JILOU Marie
25 ans
1m65, 48kg,
IMC à 17,6
Elle a perdu 5 kg (en 1 an environ) depuis la rentrée en école d'orthophonie et du fait de l'augmentation de la fréquence de ces entraînements sportifs.

Mode de vie :

Étudiante en orthophonie.
Pratique la natation synchronisée depuis ses 8 ans, en compétition.
Environ 10 heures par semaine, voire 12 heures en ce moment du fait de la préparation pour les championnats de France.
Elle n'est pas en couple actuellement mais a eu quelques relations non sérieuses.
Ne consomme ni tabac, ni alcool. Aucune allergie connue.

Comportement global :

Patiente très anxieuse de cet arrêt des règles.
Patiente habituellement "stressée", perfectionniste et très occupée par ses études d'orthophonie.

Antécédents personnels :

Otites à répétition dans l'enfance
Amygdalectomie
Adénoïdectomie

Antécédents familiaux :

HTA chez le père
Episode dépressif caractérisé chez la mère

Médicaments :

Pas de traitement
Pas de contraception (et n'en a jamais eu)

Symptômes positifs :

La patiente est asymptomatique.
Elle a toujours eu des cycles réguliers. Jamais de contraception. Pas de traitements.
Elle est anxieuse de part ses études d'orthophonie.

- Si l'étudiant(e) demande à la patiente s'il est possible qu'elle soit enceinte ET/OU si la date de son dernier rapport sexuel ET/OU si elle prenait la pilule, elle répond : "Je ne pense vraiment pas docteur. Ma dernière relation date d'il y a 6 mois. Je n'ai jamais pris la pilule, mais j'ai toujours eu des rapports protégés par une contraception mécanique…Vous croyez que je suis enceinte ?"
- Si l'étudiant(e) demande à la patiente si elle a des antécédents particuliers,

elle répond : “Pas grand chose docteur. J’avais beaucoup d’otites quand j’étais petite je crois. Et puis on m’a enlevé les amygdales et les végétations adénoïdes.”
- Si l’étudiant(e) demande à la patiente ses antécédents gynécologiques, elle répond : “Je n’ai jamais eu de grossesse, surtout pas ! Et d’ailleurs ce serait la catastrophe si je suis enceinte ! Je n’ai pas le temps, entre les études et le sport, ce serait bien trop compliqué”.
- Si l’étudiant(e) questionne la patiente sur ces cycles antérieurs, elle répond : “Je suis réglée depuis mes 13 ans. J’ai toujours eu des cycles très réguliers, assez courts tout de même. Jamais de règles très abondantes.”
- Si l’étudiant(e) demande à la patiente si elle prend des traitements /médicaments, elle répond : “Non, vraiment aucun”.
- Si l’étudiant demande à la patiente son poids et sa taille, elle répond : “Je fais très attention à mon poids docteur, c’est important pour la natation synchronisée. Je pèse 48kg actuellement et je mesure 1,65m”
- Si l’étudiant demande l’IMC de la patiente (on considère qu’elle le connaît car y fait attention), elle répond : “17 je crois”
- Si l’étudiant(e) questionne la patient(e) sur une éventuelle perte de poids récente, elle répond : “Et oui j’ai perdu 5kg cette année. Je suis un peu épuisée par tout ce sport, et mes études et je n’arrive plus vraiment à suivre.”
- Si l’étudiant(e) questionne la patiente sur son mode de vie/sa pratique sportive, elle répond : “Je pratique environ 10 à 12 heures de natation synchronisée par semaine, en compétition.”
- Si l’étudiant(e) questionne la patiente sur son alimentation, elle répond : “Je mange de tout docteur ! Mais je fais attention, j’évite le gras et le sucré”

Aucune anomalie à l’examen clinique : pas de signes d’hyperandrogénie, pas de galactorrhée, pas de signes de carence oestrogénique. Pas d’anomalie des OGE.

Constantes :

FC à 87, TA 124/83 mmHg
Apyrétique

Donnée complémentaire :

Aucune donnée complémentaire

Questions de relance :

À la 5ème minute : *“Est-ce que vous allez me prescrire une prise de sang ?”*

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Plan de la station ECOS :

Patiente assise face à l'étudiant. Un bureau et deux chaises.

Matériel nécessaire à la station :

- Feuille de brouillon pour candidat
- Stylo pour candidat
- Feuille de brouillon pour évaluateur
- Stylo pour évaluateur

Documents présents dans la station :

- Feuilles d'évaluation de papier de secours